中華民國醫師公會全國聯合會
西醫基層醫療服務審查執行會南區分會

「110 年 10 月 27 日審查專家諮詢會議」會議記錄

開會時間：110 年 10 月 27 日（三）下午 13：30
開會地點：視訊會議
出席人員：賴俊良主任委員、顏大翔副主任委員、徐超群副主任委員、趙善楷副主任委員、陳相國委員、蔡國麟秘書長、端木梁組長、李明陽副組長、楊忠錫總召、劉晉瑋副總召、葉雲宇副總召、王家麟副總召、陳俊文副總召、李昭榮副總召、魏大倫副總召、陳炳誠副總召、110 年各科召集人、中央健保署南區業務組：黃紫雲科長、洪欉皆視察、許雅婷小姐。
請假人員：丁榮哲副主任委員
會務人員：陳美惠、周芷妤
主席:端木梁審查組長　　紀錄與整理:陳美惠

一、 主席致詞
二、 各科召集人報告該科審查狀況
三、 提案討論

提案一　　提案人：審查組

案由：建請重申及討論南區糖尿病下列用藥審查共識。

說明：

一、 口服降血糖藥物Metformin使用最大耐受劑量已調低為1000mg，業已於「110年3月3日第一次南區委員會會議」通過。

二、糖尿病用藥 TZD、DPP4i、SGLT2i 三者得互相轉換：符合這三類藥物的給付規定並檢附起始治療的相關病歷與檢驗報告，經具體詳實記載新的臨床症狀，有轉換的必要時，TZD、DPP4i、SGLT2i 三者得互相轉換。例如：因水腫將 TZD 轉成 DPP4i；或有 CHF、CKD、Albuminuria 將 DPP4i(或 TZD)轉成 SGLT2i 等，業已於「110 年 5 月 26 日第二次南區委員會會議」通過。

三、什麼情況可以開立TZD，DPP4 and SGLT2 inhibitors？

1、已接受Metformin使用劑量達1000mg/day，三個月以上，且HbA1仍大於等於7%之第二型糖尿病人。

2、Metformin有禁忌症（如eGFR<30）或副作用，即可第一線開立。

3、80歲以上第二型糖尿病患者，以前未使用過Metformin者(醫師裁量)；如果病患是80歲以前就已經使用metformin 且病情穩定，Creatinine正常的病患，雖達

80歲了，仍可繼續處方metformin。

四、什麼情況可以開立DPP4/SGLT2 inhibitors複方製劑？一定要連續2次HbA1c>7.5%嗎？

1、不需要，只要第6個月的HbA1c>7.5%即可。目前健保規範為限用於已接受過最大耐受劑量的metformin，且併用 SGLT-2 或DPP-4抑制劑治療至少6個月，糖化血色素值(HbA1c)仍高於7.5%者（僅限使用有相同成分的複方製劑）。

2、可參閱南區委員會網站提供的「三高用藥查檢表」。

辦法：請討論。

決議：照案通過。

提案二　　提案人：審查組

案由：建請討論HCV reflex testing 申報方式及C型肝炎-核醣核酸類定量檢驗管控方法？

說明：

一、HCV reflex testing申報方式將自費用年月110年10月起生效。系提供另一種執行成人預防保健之C型肝炎抗體及RNA檢驗之申報方式，院所可自行選擇是否要執行HCV reflex testing。（見附件二）

二、若成人預防保健 C型肝炎篩檢陽性，俟院所執行完成 C型肝炎-核醣核酸類定量擴增試驗後,合併成人預防保健第一階段（含C型肝炎篩檢:醫令代碼L1001C)及C型肝炎-核醣核酸類定量擴增試驗(醫令代碼為12185C)申報。

三、C型肝炎抗體及RNA檢驗費用是由診所端或檢驗所端申報？是否上傳VPN雲端以資訊共享，避免重複檢驗(附件三)。

四、如何管控C型肝炎-RNA(醫令代碼為12185C)檢驗？避免重複及不需要之檢驗？

辦法：請討論。

決議：1. C 型肝炎-RNA 的檢驗要在 Anti-HCV 篩檢呈陽性後才考慮做。

2. 先在 VPN 雲端查詢未做過 C 型肝炎-RNA 檢驗後才檢測，申報費用者請將檢驗結果上傳雲端共享。

3. 建議健保署做 C 型肝炎-RNA 重複檢驗的 API 提醒。

4. 分會將建議南區業務組對 C 型肝炎-RNA 做相關的檔案分析，並討論管控方式，以避免做重複及不必要之檢驗。

提案三　　提案人：審查組

案由：建請討論有關106-108年開放表別項目中，申報金額大於預估金額之項目，南區申報情況。

說明：西醫基層醫療服務審查執行會提供106-108年開放表別項目中，申報金額大於預估金額之項目表計10項，如附件四。

辦法：建議南區業務組協助分析該些項目申報之分區別、院所科別及疾病別等相關申報資料，提委員會討論。

決議：照案通過，請健保署南區業務組分析上述相關項目後，提審查會議討論。

提案四　　提案人：審查組

案由：增列糖尿病用藥GLP-1-insulin複方針劑checklist。

說明：

一、 糖尿病用藥含lixisenatide及insulin glargine之複方製劑(Soliqua)已於110/7/1修正公告。

二、 限用於已接受過最大耐受劑量Metformin及/或 Sulfonylurea類藥物，且併用下列藥品之一持續六個月之後，HBA1c仍高於8.0%以上之第二型糖尿病成人病人(110/7/1):

(1)SGLT-2抑制劑

(2)DPP-4抑制劑

(3)SGLT-2抑制劑合併 DPP-4抑制劑複方藥品

(4)Insulin(每日劑量小於60單位)

三、本藥品不得與DPP-4抑制劑、SGLT-2抑制劑併用。

辦法：增列糖尿病用藥GLP-1-insulin複方針劑checklist供會員參考，如附件五。

決議：照案通過。

臨時提案一　　提案人：小兒科-陳信宏醫師

案由：追認建請討論欣流用藥審查方式。

說明：最近南區業務組使用電腦程式來檢核，造成欣流4mg正常開藥且不符合年齡使用的患者被行政核刪。欣流藥物，是一種氣喘與過敏性鼻炎的慢性病用藥，有4mg、5mg、

10mg 三種劑量，各有建議的使用年齡。

辦法：一、建請南區業務組重新審視欣流之行政核刪程式，是否可能誤刪？

二、若電腦發現年齡不符合的開藥，建議立意抽審，交由審查醫師來實際審查案件，了解醫師開藥的緣由，來幫病患的用藥安全做把關。

決議：健保署目前已進行程式修正，並請院所若對核刪案件有疑義時，主動聯絡業務組承辦人員以利協助處理。